PSIQUIATRIA

Ansiedade e TOC

Resumo de tutoria

NESTE CADERNO

Conteúdo de estudo, quadros, figuras e referências dos materiais fornecidos.

16 páginas de conteúdo • Texto pesquisável • Navegação por marcadores

Edição visual padronizada. Conteúdo clínico mantido a partir dos arquivos de origem; esta edição não constitui revisão ou atualização das condutas.

RESUMO · PSIQUIATRIA

Ansiedade e TOC

Resumo de alto rendimento: da ansiedade fisiológica ao TOC refratário

1. Espectro ansioso: ansiedade fisiológica × patológica e as principais apresentações clínicas.
2. TOC: alterações do pensamento, do comportamento e da personalidade.
3. Manejo terapêutico: TCC/EPR e farmacoterapia, com doses usuais.

FORMATO **RESUMO** · TEMA **ANSIEDADE E TOC** · **2026**

BLOCO 1

Definição e conceitos-chave

Medo = ameaça *presente*, objeto definido, resposta abrupta e intensa. **Ansiedade** = ameaça futura ou difusa, sem objeto claro, resposta sustentada com tensão e hipervigilância. **Angústia** enfatiza o componente somático opressivo.

A ansiedade é **adaptativa**: melhora o desempenho até o ápice de uma curva em U invertido, e o piora nos dois extremos. O alvo terapêutico é devolver o paciente à zona funcional — **não abolir a ansiedade**.

Eixo	Fisiológica	Patológica
Proporcionalidade	Proporcional ao risco real	Desproporcional; ameaça superestimada
Autonomia	Cessa com o estímulo	Persiste ou surge sem estímulo
Intensidade	Permite pensar e agir	Interrompe a ação e o raciocínio
Comportamento	Mobiliza para a solução	Esquiva, comportamento de segurança, reasseguramento
Prejuízo	Ausente ou mínimo	Prejuízo funcional ou sofrimento significativo *(critério obrigatório no DSM-5-TR)*

Tabela 1 — Os cinco eixos de patologização.

> **MACETE**
> Quatro perguntas na anamnese: **"Isso é maior do que o problema?"** · **"Passa quando acaba?"** · **"O que você deixou de fazer por causa disso?"** · **"Isso te atrapalha ou te incomoda?"**

Classificação — o que mudou

Desde o **DSM-5 (2013)** e a **CID-11 (em vigor desde 2022)**, o antigo capítulo de ansiedade foi dividido em três: *transtornos de ansiedade*; *TOC e transtornos relacionados*; *trauma e estressores*[1,2].

Transtornos de ansiedade (6B0)	TOC e relacionados (6B2)	Trauma e estressores
TAG · pânico · agorafobia · ansiedade social · fobia específica · ansiedade de separação · mutismo seletivo · induzida por substância ou condição médica	**TOC** · transtorno dismórfico corporal · acumulação · tricotilomania · escoriação. A CID-11 acrescenta hipocondria e ciúme obsessivo	TEPT · estresse agudo · transtorno de adaptação · (CID-11: TEPT complexo)

*Tabela 2 — A tripartição do antigo capítulo. Na CID-10, ainda usada no SUS: F40 fóbicos, F41 outros ansiosos, **F42 TOC**.*

> **PEGADINHA DE PROVA**
> "TOC é transtorno de ansiedade" é **falso** nas classificações vigentes. E o ataque de pânico não é diagnóstico — é *especificador* aplicável a qualquer transtorno mental.

BLOCO 2

Fisiopatologia essencial

Ansiedade

Estímulo → tálamo → duas vias. A *via rápida* (subcortical, milissegundos) chega à amígdala antes da avaliação cortical; a *via lenta* (córtex sensorial e pré-frontal) contextualiza depois. Por isso o paciente "sabe" que não vai morrer e mesmo assim sente que vai.

Amígdala → três eferências, três grupos de sintomas:

- **Hipotálamo → eixo HPA** (CRH → ACTH → cortisol): hipervigilância, insônia, tensão muscular, fadiga, irritabilidade.
- **Locus coeruleus → noradrenalina/simpático**: taquicardia, sudorese, tremor, midríase, boca seca.
- **Substância cinzenta periaquedutal e núcleo parabraquial**: congelamento, fuga, **hiperventilação → hipocapnia → parestesia, tontura, desrealização**.

Some-se o **déficit de controle inibitório do córtex pré-frontal ventromedial** e a alça do pânico: o sintoma corporal é interpretado como catástrofe, o que realimenta a amígdala.

Neurotransmissores

GABA — benzodiazepínicos são moduladores alostéricos positivos do $GABA_A$: efeito imediato, tolerância e dependência. **Serotonina** — os ISRS exigem dessensibilização de autorreceptores $5\text{-}HT_{1A}$: daí a latência de 2–6 semanas e a **piora inicial**. **Noradrenalina** — sintomas periféricos (base do propranolol na ansiedade de desempenho). **Glutamato** — consolidação e extinção do medo.

Extinção do medo

Extinção **não é apagamento**: é uma nova memória inibitória (CPF ventromedial + hipocampo) que compete com a memória de medo. Logo, é **contexto-dependente** (expor em vários contextos), **frágil** (explica recaída sob estresse) e depende de **exposição real**, não de falar sobre ela.

TOC

Circuito córtico-estriado-tálamo-cortical (CSTC). Córtex órbito-frontal e cingulado anterior detectam erro ("algo está errado") → estriado (caudado) filtra → *via direta* inibe o GPi e **desinibe o tálamo** (acelerador) enquanto a *via indireta* (GPe → núcleo subtalâmico) freia → tálamo dorsomedial reexcita o córtex, fechando a alça. No TOC há **predomínio da via direta**: a alça fica "travada em ligado" e o sinal de erro não se extingue. Esse circuito **se normaliza tanto com ISRS quanto com terapia comportamental**.

Neurotransmissores: só antidepressivos com ação serotoninérgica potente funcionam (clomipramina sim, desipramina não; bupropiona e mirtazapina não). Glutamato desregulado (base racional, ainda experimental, dos moduladores glutamatérgicos). Dopamina explica a associação com tiques e a resposta à potencialização com antipsicótico.

O modelo comportamental: por que o TOC se mantém

Pensamento intrusivo (**universal**) → avaliação disfuncional (responsabilidade inflada, fusão pensamento-ação) → **obsessão** → ansiedade/incompletude → **compulsão** → **alívio imediato = reforço negativo**. O alívio aumenta a chance de repetir o ritual e **impede a desconfirmação** da crença. Suprimir o pensamento aumenta sua frequência.

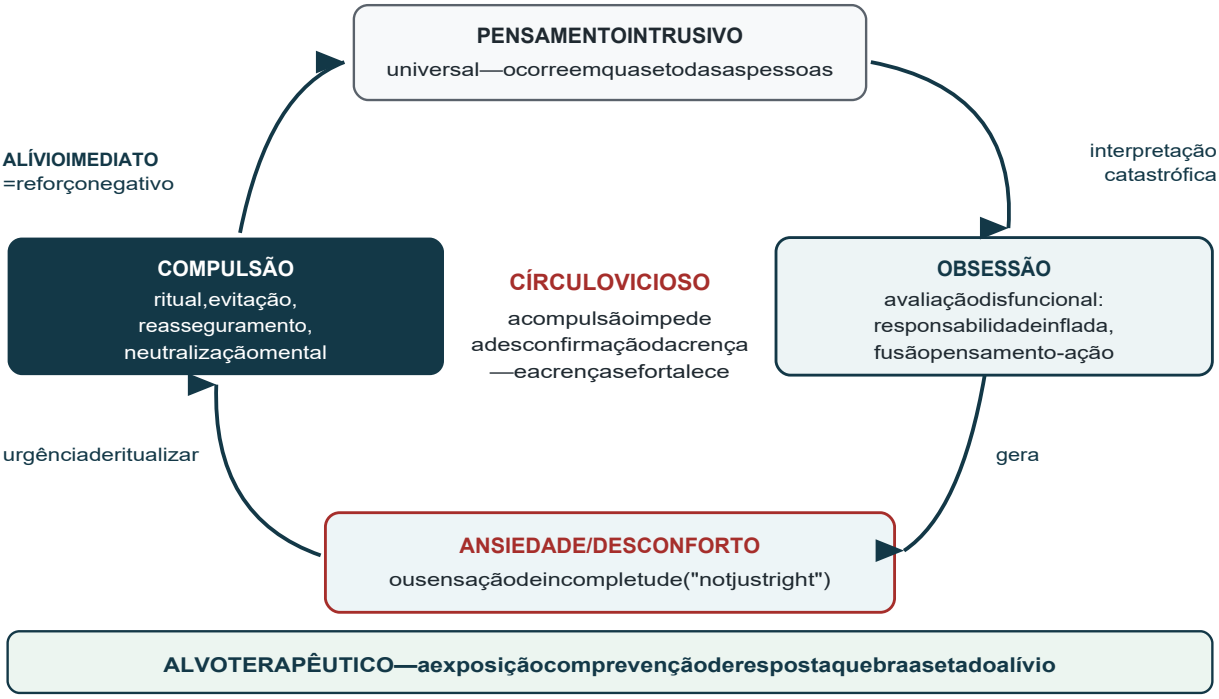


Figura 1 — Círculo vicioso obsessão–compulsão. Toda a lógica da EPR é interromper a seta verde: expor à obsessão e não permitir o ritual, até que a ansiedade caia sozinha e a crença seja desconfirmada.

> **PONTO-CHAVE**
> Esquiva, comportamento de segurança, reasseguramento e compulsão são **o mesmo fenômeno**: aliviam agora e impedem a aprendizagem corretiva depois. Por isso o núcleo terapêutico de ansiedade e TOC é o mesmo — *bloquear a resposta de alívio*.

BLOCO 3

Quadro clínico

Os transtornos do espectro ansioso

Três perguntas separam os diagnósticos: **o que se teme**, **quando se teme** e **o que se faz para não temer**.

Transtorno	Objeto do medo	Duração mínima	Critérios-chave	Comportamento típico
TAG	Múltiplos eventos futuros do cotidiano; preocupação difusa e migratória	6 meses	**3 de 6** sintomas (1 em crianças): inquietação, fatigabilidade, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, alteração do sono	Preocupar-se (é o próprio ritual), checar, reassegurar-se
Pânico	As próprias sensações corporais; morrer, enlouquecer, perder o controle	1 mês de apreensão pós-crise	Ataques recorrentes e **inesperados**: **4 de 13** sintomas, **pico em minutos**	Ir ao PS, medir a pressão, carregar medicação
Agorafobia	Situações sem fuga fácil ou socorro disponível	6 meses	**2 de 5** situações: transporte público, espaços abertos, espaços fechados, filas/multidões, sair sozinho. **Diagnóstico independente** desde o DSM-5	Evitar sair; exigir acompanhante; sentar perto da saída

Transtorno	Objeto do medo	Duração mínima	Critérios-chave	Comportamento típico
Ansiedade social	Julgamento e humilhação; ser percebido ansioso	6 meses	Especificador *somente desempenho*	Esquiva social; álcool como ansiolítico
Fobia específica	Objeto ou situação circunscrita	6 meses	Subtipos: animal, ambiente natural, **sangue–injeção–ferimento**, situacional	Esquiva do estímulo
Separação	Afastamento da figura de apego	**4 sem.** crianças / 6 meses adultos	DSM-5 reconhece a forma do adulto	Recusa escolar; queixas somáticas nos dias de separação
Mutismo seletivo	Falar em contextos sociais específicos	1 mês (não o 1º mês de escola)	Fala normalmente em outros contextos — é ansiedade, não oposição	Silêncio na escola

Tabela 3 — Espectro ansioso: objeto, tempo e comportamento.

> **PEGADINHA DE PROVA**
> **Sangue–injeção–ferimento** é a exceção fisiológica: resposta **bifásica** — taquicardia seguida de reação va-*sovagal* com bradicardia, hipotensão e **síncope**. É o único quadro fóbico em que o paciente desmaia e o único tratado com **tensão muscular aplicada** (não relaxamento).

TOC — definições precisas

Obsessão = pensamento, impulso ou imagem *recorrente, persistente, intrusivo e indesejado,* que gera sofrimento e que a pessoa tenta ignorar, suprimir ou neutralizar. É **egodistônica** (reconhecida como própria, mas alheia aos valores) e a **forma do pensamento é preservada**.

Compulsão = comportamento repetitivo **ou ato mental** executado em resposta a uma obsessão ou por regras rígidas, para reduzir ansiedade ou evitar um evento temido, **sem conexão realista** com o que pretende neutralizar.

Dimensão	Obsessões	Compulsões
Contaminação / limpeza	Sujeira, germes, fluidos, contaminação "moral"	Lavagem, banhos longos, evitação de tocar
Dano / verificação	Responsabilidade por acidente, incêndio, roubo; dúvida patológica	Verificar fogão, portas, gás; refazer o percurso
Simetria / *just right*	Exatidão, alinhamento, sensação de incompletude	Ordenar, repetir até "ficar certo", contar
Conteúdos proibidos	Agressivos, sexuais, religiosos	Rituais mentais, oração, confissão, reasseguramento, evitação
Acumulação	Medo de perder algo necessário	Guardar; impossibilidade de descartar

Tabela 4 — Dimensões sintomáticas. A de conteúdos proibidos é a mais ocultada e a de maior atraso diagnóstico.

Fenômenos sensoriais — urgência premonitória, sensações localizadas, "não está certo" — precedem o ritual em parte dos pacientes, sobretudo os de início precoce e com tiques, que respondem melhor à potencialização com antipsicótico.

BLOCO 4

Psicopatologia do TOC

Pensamento

A obsessão altera o **conteúdo** do pensamento (e o curso, por interrupção), mas **não a forma** — sem desagregação, afrouxamento ou neologismo. Daí a distinção da esquizofrenia.

Fenômeno	Convicção	Egodistonia	Resistência	Forma do pensamento
Obsessão	Reconhece como improvável/absurda	Sim	Sim, luta contra	Preservada
Ideia supervalorizada	Alta, mas admite dúvida	Parcial	Pouca	Preservada
Delírio	Absoluta, irredutível	Não (egossintônico)	Ausente	Pode estar alterada; outros sintomas psicóticos

*Tabela 5 — Gradiente de convicção. **TOC com insight ausente continua sendo TOC**, não psicose.*

Crenças disfuncionais nucleares (alvo da reestruturação cognitiva)

- **Responsabilidade inflada** — "se eu não impedir, a culpa é minha" (motor da verificação).
- **Superestimação da ameaça** — probabilidade e gravidade superavaliadas.
- **Fusão pensamento–ação** — *moral* (pensar equivale a fazer) e *de probabilidade* (pensar aumenta a chance).
- **Importância e controle do pensamento** — suprimir aumenta a intrusão.
- **Intolerância à incerteza** — motor da dúvida patológica.
- **Perfeccionismo** — existe uma solução perfeita e errar é inaceitável.

Comportamento — quatro classes funcionalmente equivalentes

1. **Compulsões manifestas** — lavar, verificar, ordenar, repetir.
2. **Compulsões mentais** — contar, rezar, repetir frases, revisar memórias, neutralizar imagens.
3. **Evitação** — não tocar, não dirigir, não ficar sozinho com o bebê. Ritual "econômico".
4. **Busca de reasseguramento** — perguntar aos familiares, pesquisar na internet, consultar médicos em série. Compulsão *terceirizada*.

Somam-se a **lentificação obsessiva** e o **esquivamento da responsabilidade**.

Acomodação familiar: a maioria das famílias participa dos rituais (verificar pelo paciente, responder ao reasseguramento, aceitar regras). Alivia agora e **mantém o transtorno**; associa-se a maior gravidade e pior resposta. **Toda intervenção deve incluir a família**, com retirada gradual e negociada da acomodação.

Personalidade — TOC não é TPOC

Aspecto	TOC (transtorno)	TPOC (personalidade / anancástica)
Natureza	Síndrome com início identificável	Padrão pervasivo desde o início da vida adulta
Relação com o self	**Egodistônico** — o paciente sofre	**Egossintônico** — sofre o entorno
Fenômeno central	Obsessões e compulsões definidas	Ordem, perfeccionismo e controle **à custa de flexibilidade e eficiência**

Aspecto	TOC (transtorno)	TPOC (personalidade / anancástica)
Manifestações	Lavar, verificar, contar, ordenar por obsessão específica	Perfeccionismo que impede concluir; devoção ao trabalho; inflexibilidade moral; não descartar objetos; não delegar; avareza; rigidez
Insight	Geralmente presente	Tipicamente ausente
Tratamento	ISRS em dose alta + EPR	Psicoterapia de longo prazo; **sem indicação de ISRS pelo transtorno em si**

Tabela 6 — TOC × TPOC. A maioria dos pacientes com TOC não tem TPOC, e vice-versa.

> **MACETE**
> Uma pergunta separa os dois: **"Você gostaria de deixar de ser assim?"** No TOC, sim, aliviado. No TPOC: "por quê? o problema são os outros". *Sofre o paciente* → TOC. *Sofre quem convive* → TPOC.

BLOCO 5

Diagnóstico

Critérios do TOC (DSM-5-TR)

1. **A.** Obsessões, compulsões ou ambas.
2. **B.** Consomem **> 1 hora/dia** *ou* causam sofrimento/prejuízo clinicamente significativo. **Não há critério de duração mínima.**
3. **C.** Não atribuíveis a substância ou condição médica. **D.** Não mais bem explicadas por outro transtorno.
4. **Especificadores obrigatórios:** insight *bom/razoável*, *pobre* ou *ausente/delirante*; e relacionado a tique.

> **ATENÇÃO**
> O DSM-IV exigia que o paciente reconhecesse os sintomas como excessivos. O DSM-5 removeu essa exigência e criou o especificador de insight. Consequência: insight ausente **não** transforma TOC em esquizofrenia — o tratamento continua sendo ISRS em dose alta + EPR, eventualmente com potencialização antipsicótica.

Instrumentos e pontos de corte

Instrumento	Escala	Interpretação
GAD-7	0–21	≥ 5 leve · **≥ 10 corte de rastreio** · ≥ 15 grave
GAD-2	0–6	≥ 3 positivo → aplicar o GAD-7
Y-BOCS	0–40	0–7 subclínico · 8–15 leve · 16–23 moderado · **24–31 grave** · 32–40 extremo. **Resposta = queda ≥ 35%**; remissão ≤ 12
DY-BOCS · BABS	—	Avaliação dimensional do TOC e do insight (forte contribuição brasileira)

*Tabela 7 — Escala não faz diagnóstico: rastreia, gradua e **mede resposta ao longo do tempo**.*

Rastreamento e investigação

Duas perguntas de rastreio de TOC devem entrar em toda avaliação de paciente ansioso — o paciente não relata espontaneamente: *"Você tem pensamentos ou imagens repetitivos que entram na sua cabeça sem querer e te incomodam?"* e *"Você sente necessidade de repetir algo — checar, lavar, contar, rezar —*

para se sentir melhor?". Pergunte explicitamente sobre conteúdos agressivos, sexuais e religiosos, normalizando-os.

Não existe "rotina de ansiedade". A investigação é dirigida pela anamnese; quando indicada, o mínimo razoável é hemograma, glicemia, **TSH** e **ECG**. Em 2023 a USPSTF passou a recomendar rastreamento de ansiedade em adultos de **19 a 64 anos**, incluindo gestantes e puérperas (**grau B**), com evidência insuficiente acima de 65 anos[7] — recomendação baseada em evidência indireta e **sem equivalente nacional** no Brasil.

BLOCO 6

Diagnóstico diferencial

Excluir primeiro o que não é psiquiátrico

Grupo	Causas	Pista
Endócrinas	Hipertireoidismo, hipoglicemia, feocromocitoma, Cushing	**TSH/T4L** é o maior rendimento; HAS paroxística + cefaleia + sudorese → metanefrinas
Cardiorrespiratórias	Arritmias (TSV), SCA, IC, asma, DPOC, TEP	FC > 150 com término abrupto sugere TSV, não pânico
Neurológicas	Epilepsia de lobo temporal, doença vestibular, encefalite autoimune	Aura, automatismos, amnésia do episódio, sinais focais
Substâncias — uso	Cafeína, nicotina, cocaína, anfetaminas, cannabis	Quantificar café e energéticos: causa muito subestimada
Substâncias — abstinência	**Álcool**, benzodiazepínicos, opioides	Tremor, sudorese, taquicardia, alucinose — emergência
Medicamentos	Corticoides, β_2-agonistas, levotiroxina em excesso, descongestionantes, estimulantes, isotretinoína, teofilina	Relação temporal com início ou ajuste de dose

*Tabela 8 — Ansiedade secundária. **Sinais de alerta:** início após os 40 anos, sintomas predominantemente somáticos, exame físico alterado, ausência de resposta a tratamento adequado.*

Diferencial do TOC

Condição	O que a diferencia
TAG	Preocupação sobre *problemas reais*, plausível e sentida como própria; no TOC o conteúdo é improvável ou moralmente inaceitável, egodistônico, **com rituais estereotipados**
TPOC	Egossintônico, sem obsessões e compulsões definidas
Tiques	Rápidos, urgência puramente sensorial, sem obsessão cognitiva prévia. Podem coexistir
TEA	Rituais *egossintônicos e prazerosos*, desde a primeira infância, com déficit de comunicação social
Esquizofrenia	Forma do pensamento alterada, alucinações, desorganização, sintomas negativos. Na *inserção de pensamento* o pensamento é vivido como colocado por outrem
Depressão	Ruminação sobre o *passado*, congruente com o humor e **sem compulsão**
Hipocondria	Medo de *ter* doença; no TOC de contaminação, medo de *contrair ou transmitir*, com rituais de limpeza

Condição	O que a diferencia
Impulsões (jogo, compras)	Egossintônicas, buscam *prazer*; a compulsão busca *alívio*

Tabela 9 — Diferencial do TOC.

> **ATENÇÃO**
> **Obsessão agressiva não indica risco de violência** — é o oposto: o paciente evita a situação e sofre com o pensamento. Interpretá-la como intenção reforça a crença de que ele é perigoso, aumenta a vergonha e atrasa o tratamento.

BLOCO 7

Tratamento

Princípios

1. Avaliar **gravidade e risco** antes de escolher (suicídio, substâncias, comorbidades).
2. **Psicoeducação é intervenção**, não introdução.
3. **Cuidado escalonado**: leve → intervenção de baixa intensidade; moderado → TCC ou ISRS; grave → **combinação desde o início**[5].
4. Psicoterapia e fármaco são **parceiros**: TCC é a psicoterapia de 1ª linha e ISRS/IRSN os fármacos de 1ª linha em ambos os grupos[3,4].
5. **Dose adequada por tempo adequado** — a "falha" mais comum é subdosagem ou interrupção precoce.
6. **Medir** (GAD-7, Y-BOCS) a cada reavaliação.

TCC e exposição com prevenção de resposta (EPR)

A **EPR** expõe deliberadamente ao gatilho e **impede o ritual** — inclusive mental, a evitação e o reasseguramento. O que se aprende não é só que "a ansiedade cai", mas que a **catástrofe prevista não ocorre** e que se é **capaz de tolerar** a ansiedade.

Como se conduz: mapear obsessões, compulsões manifestas *e mentais*, evitações e reasseguramentos → construir hierarquia (0–100) → começar por itens intermediários (40–50) → expor e prevenir a resposta → repetir em **múltiplos contextos** (a extinção é contexto-dependente) → tarefas entre sessões (é onde ocorre a maior parte do tratamento) → retirar a acomodação familiar.

Transtorno	Técnica característica
Pânico	**Exposição interoceptiva**: hiperventilar, girar, respirar por canudo — provocar a sensação temida para desconfirmar a interpretação catastrófica
Agorafobia	Exposição *in vivo* graduada + retirada dos comportamentos de segurança
Ansiedade social	Exposição social + experimentos comportamentais; reduzir foco atencional interno
Fobia específica	Exposição *in vivo*, muitas vezes eficaz em **sessão única prolongada**; no subtipo sangue–injeção, associar **tensão muscular aplicada**
TAG	Crenças metacognitivas sobre a utilidade da preocupação; tolerância à incerteza; adiamento programado
TOC	**EPR** + reestruturação cognitiva + retirada da acomodação familiar

Tabela 10 — Técnicas por transtorno. Denominador comum: aproximar do que se evita e bloquear o que alivia.

CONDUTA PRÁTICA

Reasseguramento médico é ritual. Responder pela quinta vez "não, não tem risco" alivia agora e piora depois. Nomeie: *"essa pergunta faz parte do TOC; responder de novo alimenta o ciclo — vamos ficar com a incerteza."* Combine isso com o paciente e a família.

Farmacoterapia — transtornos de ansiedade

REGRA DE OURO

Comece com metade da dose inicial habitual. Pacientes ansiosos, sobretudo com pânico, têm piora paradoxal da ansiedade nos primeiros dias de ISRS. Avise antes — é a principal causa de abandono na 1ª semana.

Fármaco	Classe	Dose inicial	Faixa usual	Observação
Sertralina	ISRS	25 mg/dia	50–200 mg/dia	Poucas interações; opção preferida na gestação
Escitalopram	ISRS	5 mg/dia	10–20 mg/dia	Atenção ao QT em doses altas e idosos
Fluoxetina	ISRS	10 mg/dia	20–60 mg/dia	Meia-vida longa; mais ativação inicial. **Disponível no SUS**
Paroxetina	ISRS	10 mg/dia	20–50 mg/dia	Mais sedação, ganho de peso e descontinuação difícil. **Evitar na gestação**
Venlafaxina XR	IRSN	37,5 mg/dia	75–225 mg/dia	Monitorar PA acima de 150 mg/dia
Duloxetina	IRSN	30 mg/dia	60–120 mg/dia	Útil se há dor crônica; evitar em hepatopatia
Pregabalina	Modulador de canal de Ca^{2+}	75 mg/dia	150–600 mg/dia	1ª linha **só no TAG**; início rápido; ajustar na insuficiência renal
Buspirona	Agonista parcial 5-HT_{1A}	15 mg/dia	20–60 mg/dia	Alternativa no TAG; **ineficaz no pânico e no TOC**
Propranolol	Betabloqueador	10–40 mg	Uso pontual	Só sintomas periféricos na ansiedade de desempenho

*Tabela 11 — Adultos sem insuficiência orgânica. Avaliar resposta em **4–6 semanas**; manter **6–12 meses após a remissão** e retirar gradualmente*[3,10].

Benzodiazepínicos

Indicação racional: sintomas graves na fase inicial, enquanto o ISRS não age. **Duração: 2–4 semanas**, não excedendo 4–6, com **data de término definida desde a prescrição**. Clonazepam 0,25–2 mg/dia · alprazolam 0,25–2 mg/dia · diazepam 5–20 mg/dia · lorazepam 1–4 mg/dia. **Evitar** em transtorno por uso de substâncias, apneia do sono, gestação e idosos (queda, fratura, delirium); risco de depressão respiratória com opioides. **Retirada**: 10–25% da dose a cada 1–2 semanas, mais lento no final.

PEGADINHA DE PROVA

Benzodiazepínico não trata TOC — sem eficácia sobre obsessões e compulsões — e **atrapalha a EPR**, porque bloqueia justamente a ansiedade que precisa ser tolerada durante a exposição.

Farmacoterapia — TOC: três diferenças

1. Dose maior · **2. Ensaio de 10–12 semanas** na dose máxima tolerada · **3. Manutenção de 1–2 anos ou mais**[4].

Fármaco	Dose inicial	Dose usual no TOC	Observação
Fluoxetina	20 mg/dia	40–60 mg/dia (até 80)	**Disponível no SUS**
Sertralina	50 mg/dia	150–200 mg/dia	Também aprovada em crianças e adolescentes
Fluvoxamina	50 mg/dia	200–300 mg/dia	Muitas interações (CYP1A2, CYP2C19)
Paroxetina	20 mg/dia	40–60 mg/dia	Pior descontinuação
Escitalopram	10 mg/dia	20 mg/dia	Acima de 20 mg é *off-label*; atenção ao QT
Citalopram	20 mg/dia	40 mg/dia	**Máx. 40 mg**; 20 mg se > 60 anos ou hepatopatia (QT)
Clomipramina	25 mg/dia	100–250 mg/dia (**máx. 250**)	2ª linha. Anticolinérgicos, sedação, hipotensão, **reduz limiar convulsivo**, cardiotóxica em superdosagem. **ECG** antes e em doses altas. **Disponível no SUS**

Tabela 12 — Titular ao longo de 4–6 semanas até a dose-alvo.

O que NÃO trata TOC

Antidepressivos não serotoninérgicos (bupropiona, mirtazapina, desipramina, nortriptilina) · benzodiazepínicos em monoterapia · **antipsicóticos em monoterapia** — explicitamente desaconselhados pelo NICE[5]; têm papel apenas como *potencializadores*.

Falha terapêutica e refratariedade

Antes de escalar, cinco perguntas: o diagnóstico está correto? a dose e o tempo foram suficientes? houve adesão real? a EPR foi *de fato* feita (com tarefas de casa e prevenção de rituais mentais)? há comorbidade não tratada?

Sequência: otimizar dose → trocar de ISRS → intensificar EPR → clomipramina → **potencializar com antipsicótico** (risperidona 0,5–3 mg/dia ou aripiprazol 5–15 mg/dia, associados ao ISRS; benefício maior no subgrupo **com tiques**; monitorar peso, metabólico, prolactina e extrapiramidais)[4] → centro especializado.

Neuromodulação. A **EMT profunda** foi autorizada pela FDA em 2018 como tratamento *adjuvante* do TOC em adultos, com ~38% de resposta contra 11% no *sham*[13]. A **estimulação cerebral profunda** foi aprovada em 2009 sob *Humanitarian Device Exemption* — regime que avalia primariamente **segurança**, não eficácia. Nenhuma substitui a EPR: paciente encaminhado sem EPR adequada não é refratário, é subtratado. Moduladores glutamatérgicos (memantina, NAC, riluzol) permanecem com evidência limitada.

BLOCO 8

Fluxograma de conduta

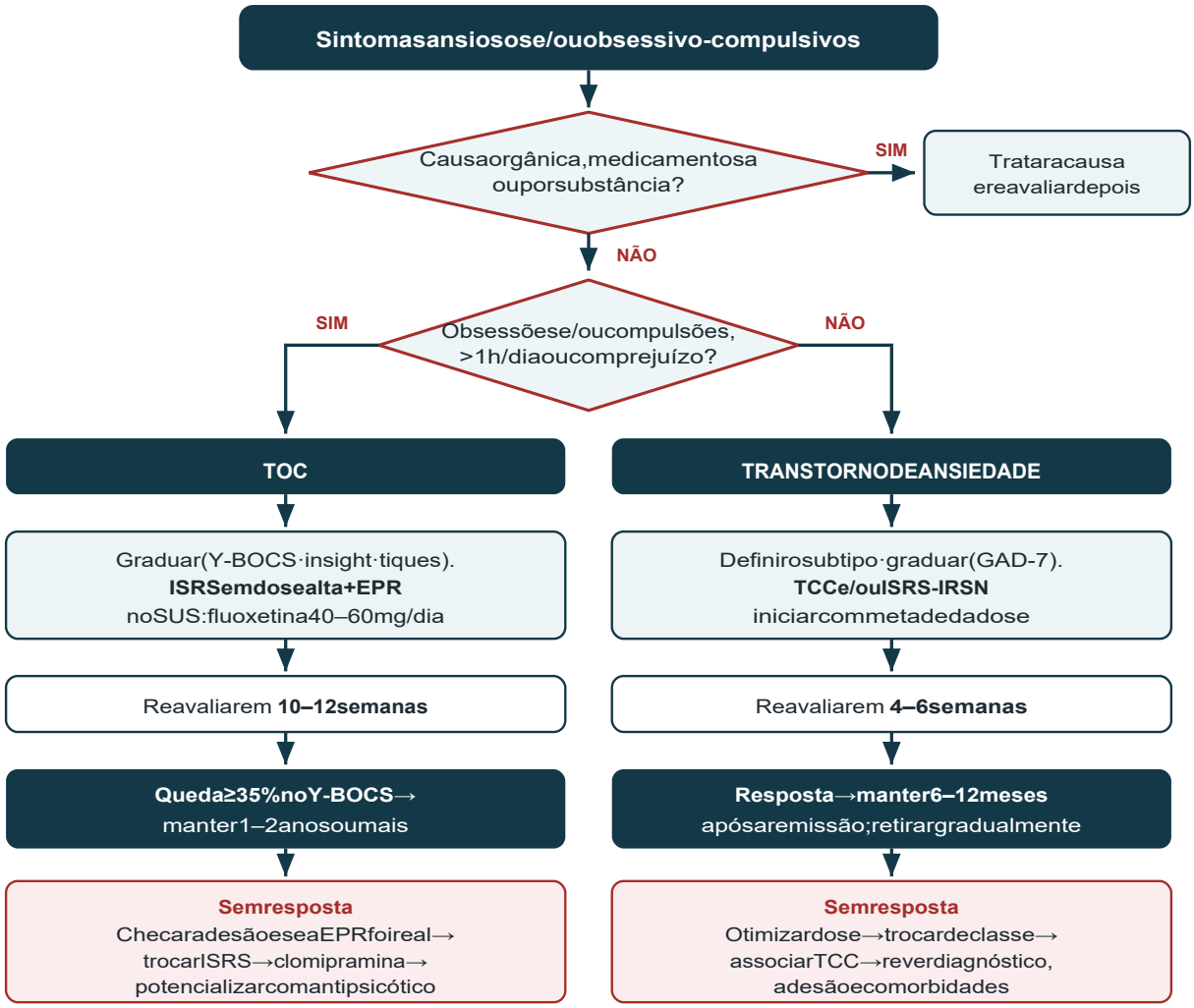


Figura 2 — Algoritmo condensado de conduta. As duas diferenças estruturais entre as colunas são a janela de reavaliação (10–12 semanas no TOC contra 4–6 na ansiedade) e a duração da manutenção (1–2 anos contra 6–12 meses). Em ambos os ramos, antes de declarar falha, verifique dose, adesão e se a psicoterapia realizada foi de fato exposição.

BLOCO 9

Complicações e situações especiais

Complicações

Depressão secundária (a mais frequente) · uso nocivo de álcool e sedativos como automedicação · prejuízo funcional acumulado (abandono escolar, desemprego, isolamento) · complicações clínicas diretas (dermatite por lavagem, lesões por escoriação, desnutrição por evitação alimentar) · **risco de suicídio elevado no TOC**, sobretudo com depressão comórbida e obsessões de conteúdo inaceitável — avalie ativamente · sobrecarga familiar agravada pela acomodação.

Prognóstico. Curso crônico e flutuante nos dois grupos. No TOC, melhora substancial em cerca de metade a dois terços dos tratados, com sintomas residuais frequentes; remissão completa é menos comum em adultos que em crianças. Pior prognóstico: início muito precoce, longa duração sem tratamento, insight pobre, comorbidades, acomodação familiar intensa, recusa da exposição.

Situações especiais

Situação	Conduta
Crianças e adolescentes	**EPR é 1ª linha** em quadros leves a moderados, com envolvimento familiar. Fármacos com evidência: sertralina, fluvoxamina, fluoxetina, clomipramina — iniciar em dose reduzida (ex.: sertralina 25 mg/dia). Monitorar **ideação suicida** nas primeiras semanas e a cada mudança de dose[4,5]
Gestação	Psicoterapia primeiro nos quadros leves/moderados. Se medicar: monoterapia, menor dose eficaz, **sertralina** como preferida; **evitar paroxetina** e benzodiazepínicos. **Não suspender abruptamente** medicação eficaz
Puerpério	Obsessões agressivas dirigidas ao bebê são comuns e ocultadas por medo de julgamento. Perguntar, normalizar e **diferenciar de psicose puerperal** (delírio, alucinação, desorganização, ausência de crítica)
Idosos	Começar baixo. **Hiponatremia por SIADH** e risco de sangramento com ISRS; evitar benzodiazepínicos e anticolinérgicos (clomipramina, hidroxizina); citalopram **máx. 20 mg**. Ansiedade de início recente exige investigação clínica e cognitiva
Insuf. renal / hepática	Renal: reduzir **pregabalina** conforme clearance. Hepática: reduzir ISRS e **evitar duloxetina**; cautela com clomipramina
Transtorno bipolar	Antidepressivo em monoterapia pode induzir virada. Estabilizar primeiro; priorizar EPR
Crise de pânico no PS	Excluir causa orgânica proporcionalmente ao risco (ECG, glicemia, saturação) → ambiente calmo → respiração lenta e controlada (**não usar saco de papel**) → benzodiazepínico só se crise prolongada, dose única → **não dar alta sem explicar o diagnóstico e encaminhar**

Tabela 13 — Situações que mudam a conduta.

BLOCO 10

Contexto brasileiro

- **Epidemiologia.** Prevalência-ano de transtornos de ansiedade de **19,9%** na região metropolitana de São Paulo — a maior entre os sítios do consórcio internacional da OMS[8]. TOC: prevalência-ano ~1% e ao longo da vida **2–2,5%**, historicamente subdiagnosticado pela natureza egodistônica e vergonhosa dos sintomas[9].
- **A sertralina não consta na Rename 2024** — não integra o Componente Básico, o Estratégico nem o Especializado[11,12]. Os antidepressivos padronizados nacionalmente pelo Componente Básico incluem **fluoxetina, clomipramina, amitriptilina e nortriptilina**. Estados e municípios podem ampliar as listas (Resme/Remume), mas a disponibilidade é local e variável.
- **Dupla realista no SUS para TOC:fluoxetina 40–60 mg/dia** (até 80) em 1ª linha e **clomipramina 100–250 mg/dia** em 2ª. Prescrever sertralina 200 mg e presumir que o paciente vai obtê-la é receita para não adesão — consulte a Remume do município.
- **Rede.** Quadros leves e moderados são de competência da Atenção Primária, com apoio matricial; **CAPS** destina-se prioritariamente a transtornos graves e persistentes. TOC grave, com prejuízo importante ou risco, é encaminhamento apropriado.
- **O gargalo não é o medicamento, é a EPR.** Terapeutas treinados em exposição são escassos fora dos grandes centros. Alternativas: grupos de TCC na APS/CAPS, psicoeducação familiar sistemática e TCC pela internet — que a WFSBP registra como superior a controles ativos no TOC[4].
- **Não há PCDT do Ministério da Saúde** para TOC ou transtornos de ansiedade; as condutas derivam de diretrizes internacionais adaptadas. E a diretriz de referência do NICE para TOC é de **2005**, com atualização prevista para **janeiro de 2027**[5,6].

BLOCO 11

Pontos de prova e pegadinhas

Alto rendimento

- **TOC não é transtorno de ansiedade** desde o DSM-5 (2013) e a CID-11.
- **Ataque de pânico é especificador**, não diagnóstico.
- Duração: **6 meses** (TAG, fobia específica, ansiedade social, agorafobia, separação em adultos) · 4 semanas (separação em crianças) · **1 mês** de apreensão pós-crise (pânico) · TOC: sem critério de duração — > 1 h/dia ou prejuízo.
- Contagens: TAG **3 de 6** (1 em crianças) · pânico **4 de 13**, pico em minutos · agorafobia **2 de 5**.
- Escalas: GAD-7 corte ≥ 10, grave ≥ 15 · Y-BOCS 0–40, **grave ≥ 24**, resposta ↓ ≥ 35%, remissão ≤ 12.
- 1ª linha no TOC: **ISRS + TCC com EPR**. Clomipramina é 2ª linha. Antipsicótico só como potencializador.
- TOC: doses **altas**, ensaio de **10–12 semanas**, manutenção **1–2 anos ou mais**. Ansiedade: doses habituais, avaliação em **4–6 semanas**, manutenção **6–12 meses** após a remissão.
- Limites: **clomipramina 250 mg/dia** (convulsão) · **citalopram 40 mg/dia**, 20 mg se > 60 anos (QT).
- Fobia sangue–injeção–ferimento: resposta **vasovagal bifásica** com síncope; tratar com **tensão muscular aplicada**.
- Gestação: preferir **sertralina**; evitar paroxetina e benzodiazepínicos.
- Pregabalina é 1ª linha **só no TAG**; buspirona é ineficaz no pânico e no TOC.

Pegadinhas

PEGADINHA DE PROVA

1. **TOC × TPOC:** egodistônico com sofrimento próprio = TOC; egossintônico, rígido, com sofrimento alheio = TPOC. TPOC **não** se trata com ISRS pelo transtorno em si.
2. **Compulsão × impulsão:** compulsão busca *alívio* e é egodistônica; impulsão (jogo, compras) busca *prazer* e é egossintônica.
3. **Obsessão × delírio:** a obsessão preserva a forma do pensamento. Insight ausente **não** converte TOC em esquizofrenia.
4. **Obsessão × inserção de pensamento:** na inserção o pensamento é vivido como *colocado por outrem*; na obsessão, como próprio, porém indesejado.
5. **Compulsão mental existe:** contar e rezar em silêncio são compulsões. "TOC puramente obsessivo" quase sempre tem rituais mentais não perguntados.
6. **Obsessão agressiva não é risco de violência** — o paciente evita e sofre.
7. **ISRS pode piorar a ansiedade no início:** comece com metade da dose e avise.
8. **Benzodiazepínico não trata TOC** e atrapalha a EPR.
9. **Saco de papel** na crise de pânico é conduta obsoleta e potencialmente perigosa.
10. **Ruminação depressiva não é obsessão** — é sobre o passado, congruente com o humor, e não gera compulsão.

BLOCO 12

Revisão em 30 segundos

Ansiedade fisiológica × patológica: desproporção, autonomia, intensidade intolerável, esquiva e prejuízo. O alvo é a zona funcional, não a ausência de ansiedade.

Classificação: desde 2013 o TOC tem capítulo próprio. Ataque de pânico é especificador. Agorafobia é diagnóstico independente. CID-10 no SUS: F40, F41, **F42**.

Mecanismo: na ansiedade, amígdala hiperativa com controle pré-frontal deficiente e três eferências (HPA, locus coeruleus, periaquedutal) que explicam cada sintoma; no TOC, alça CSTC travada em "ligado". Em ambos, o comportamento de alívio (esquiva ou compulsão) é o que mantém a doença — e é o alvo do tratamento.

Diferencie: o que se teme, quando se teme e o que se faz para não temer. TAG = preocupação difusa com problemas reais; pânico = medo do próprio corpo; TOC = obsessão egodistônica + ritual estereotipado; TPOC = perfeccionismo egossintônico.

Trate: TCC/EPR + ISRS em ambos. Ansiedade — metade da dose para começar, avaliar em 4–6 semanas, manter 6–12 meses após a remissão. TOC — dose alta, avaliar em 10–12 semanas, manter 1–2 anos; clomipramina em 2ª linha; antipsicótico só potencializando. Benzodiazepínico: 2–4 semanas, com data de término, nunca no TOC.

No SUS: sertralina não está na Rename 2024; use **fluoxetina** em dose alta e **clomipramina**. O gargalo real é o acesso à EPR.

REFERÊNCIAS

Referências utilizadas

1. American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR)*. Washington, DC: APA Publishing; 2022.
2. Organização Mundial da Saúde. *CID-11*, versão em vigor desde janeiro de 2022. Agrupamentos 6B0 e 6B2. Disponível em: https:/icd.who.int/browse11
3. Bandelow B, Allgulander C, Baldwin DS, et al. WFSBP guidelines for treatment of anxiety, obsessive-compulsive and posttraumatic stress disorders — Version 3. Part I: Anxiety disorders. *World J Biol Psychiatry*. 2023;24(2):79-117. doi: 10.1080/15622975.2022.2086295. PMID: 35900161
4. Bandelow B, Allgulander C, Baldwin DS, et al. WFSBP guidelines... — Version 3. Part II: OCD and PTSD. *World J Biol Psychiatry*. 2023;24(2):118-134.
5. National Institute for Health and Care Excellence. *Obsessive-compulsive disorder and body dysmorphic disorder: treatment*. Clinical guideline [CG31]. Londres: NICE; 2005. Disponível em: https:/www.nice.org.uk/guidance/cg31
6. NICE. *Obsessive-compulsive disorder and body dysmorphic disorder: assessment and management* — diretriz em desenvolvimento (GID-NG10435), publicação prevista para janeiro de 2027. Disponível em: https:/www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ng10435
7. US Preventive Services Task Force; Barry MJ, Nicholson WK, Silverstein M, et al. Screening for Anxiety Disorders in Adults: USPSTF Recommendation Statement. *JAMA*. 2023;329(24):2163-2170. doi:10.1001/jama.2023.9301. PMID: 37338866
8. Andrade LH, Wang YP, Andreoni S, et al. Mental disorders in megacities: findings from the São Paulo Megacity Mental Health Survey, Brazil. *PLoS ONE*. 2012;7(2):e31879. doi:10.1371/journal.pone.0031879
9. Torres AR, Lima MCP. Epidemiologia do transtorno obsessivo-compulsivo: uma revisão. *Rev Bras Psiquiatr*. 2005;27(3):237-242.
10. Bandelow B, Werner AM, Kopp I, et al. The German Guidelines for the treatment of anxiety disorders: first revision. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci*. 2021. doi:10.1007/s00406-021-01324-1
11. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 6.324, de 26 de dezembro de 2024 — estabelece a Rename 2024. Disponível em: https:/bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2024/prt6324_30_12_2024.html

12. InfoSUS — Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. Verbetes "Sertralina" (não pertence ao elenco da Rename 2024) e "Clomipramina, cloridrato" (Componente Básico). Disponível em: http:/infosus.saude.sc.gov.br/index.php/Sertralina
13. U.S. Food and Drug Administration. *FDA permits marketing of transcranial magnetic stimulation for treatment of obsessive compulsive disorder*. Comunicado de imprensa; 17 de agosto de 2018.

Doses e critérios devem ser confirmados em bula vigente e nas diretrizes originais antes da aplicação clínica.